



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : مديحه حجاج ابراهيم محمود

العنوان : 0

الحى / المدينة : ابوالنمرس

المحافظة : الجيزه

تاريخ تسجيل الإستماره : 03-10-2026

رقم البطاقة : 26712242101047 رقم التليفون : 01035639680

العمر (تاريخ الميلاد) : 24-12-1967 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي

المقر بما فيه

التوقيع: (-----) (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني

الاسم : د/ندى حسن

الاسم : د/نرمين رمضان

الوظيفة : -----

الوظيفة : -----

الوظيفة : -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----

خطة العلاج : -----

المستشفى : -----

قسم : -----

جهة العلاج : -----

نفقات : -----

ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: مديحه حجاج ابراهيم محمود National ID: 26712242101047	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الى Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

مديحه
حجاج ابراهيم محمود
قرية منيل شبيحة
مركز أبو التمرس - الجيزة

١٩٦٧/١٢

٢٦٧١٢٢٤٢١٠١٠٤٧

LE3034924

٠١٠٢٥٦٣٩٦٨٠

٠١--٩٨٨٩٥٩٨



٢٠٢٥/٠٥ ٢٦٧١٢٢٤٢١٠١٠٤٧

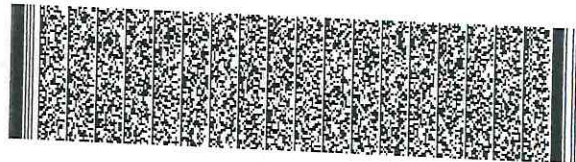
بدون عمل

مسلمة

أنثى



البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٥/٢٧



Name : Madeeha Hagag

Date:19/08/2026

Digitalized Low Dose Soft Tissue Mammography With Complementary Breast US Examination Of LT Breast Revealed:

- ACR B = few scattered glandular tissue
- An ill-defined speculated hyper dense lesion is seen at the UOQ , breast corresponding by US to an ill defined globular shaped heterogeneous hypoechoic lesion is seen at 2 o'clock surrounded by echogenic halo and causing posterior shadowing. The lesion shows spiculations to the related duct and near to the skin seen at 2 O'clock zone B away from nipple 5.5 cm and from skin 0.73 cm , yet no skin infiltration or nipple retraction. It measures
- Few axillary LNs , almost are non specific with one seen rounded with relative loss of fatty hilum measuring 14.4 x 12.4 mm

Opinion:

- LT breast UOQ malignant looking lesion associated with ipsilateral axillary lymphadenopathy Level I (BIRADS V) for biopsy

Thanks ,

Dr. Sara Khatab

Radiological Consultant

BIRADS scoring is the breast imaging and reporting data system for classifying the radiological diagnosis of breast lesions:

BIRADS 0 : Needs further investigations.

BIRADS 1: Normal findings.

BIRADS 2: Benign.

BIRADS 3: Probably benign.

BIRADS 4: Probably malignant.

BIRADS 5: Malignant.

BIRADS 6: Proven pathologically malignant







Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترنشنال - مصر - مصر - مصر - مصر



Patient Name	مدى حجاج ابراهيم	Case No.	361841
Sex/Age	Female 58 Y	Patient No.	26568
Registered Date	01/9/2026 09:52:35 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	26/9/2026 12:29:43 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	01/10/2026 09:32:33 AM	Pathology No.	2812/26

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 7/09/2026, cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

Four grayish, white tissue cores, ranging in size between 0.6 cm & 2.0 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for.
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 3 (differentiation 3, pleomorphism 3, mitosis 2)
- DCIS: Absent
- Micrometastasis: Absent
- Angiolymphatic invasion: Absent
- Perineural invasion: Absent
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Mild

Results:

- * IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 15% of tumor cells (score 6/8).
- Her2: No membrane staining in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 50%.

Conclusion:

- Left breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma, Grade 2.
- IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 6/8).

Patient Name	مديحه حجاج ابراهيم	Case No.	361841
Sex/Age	Female 58 Y	Patient No.	26568
Registered Date	01/9/2026 09:52:35 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	26/9/2026 12:29:43 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	01/10/2026 09:32:33 AM	Pathology No.	2812/26

- Her2: Negative (score 0).

- Ki67%: 50%.

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of

the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghonain, MD.

Name : Madeeha Hagag

Date:19/08/2026

Digitalized Low Dose Soft Tissue Mammography With

Complementary Breast US Examination Of LT Breast Revealed:

- ACR B = few scattered glandular tissue
- An ill-defined speculated hyper dense lesion is seen at the UOQ , breast corresponding by US to an ill defined globular shaped heterogeneous hypoechoic lesion is seen at 2 o'clock surrounded by echogenic halo and causing posterior shadowing. The lesion shows spiculations to the related duct and near to the skin seen at 2 O'clock zone B away from nipple 5.5 cm and from skin 0.73 cm , yet no skin infiltration or nipple retraction. It measures
- Few axillary LNs , almost are non specific with one seen rounded with relative loss of fatty hilum measuring 14.4 x 12.4 mm

Opinion:

- LT breast UOQ malignant looking lesion associated with ipsilateral axillary lymphadenopathy Level I (BIRADS V) for biopsy

Thanks ,

Dr. Sara Khatab

Radiological Consultant

BIRADS scoring is the breast imaging and reporting data system for classifying the radiological diagnosis of breast lesions:

BIRADS 0 : Needs further investigations.

BIRADS 1: Normal findings.

BIRADS 2: Benign.

BIRADS 3: Probably benign.

BIRADS 4: Probably malignant.

BIRADS 5: Malignant.

BIRADS 6: Proven pathologically malignant